

Idealizacja — *dewaluacja*

Klasyczny splitting Kleina/Kernberga. Partner „idealny” → potem „bezwartościowy”. Niemożność integracji dobrych i złych aspektów w jednym obrazie. TFP osiąga remisję u ~50% po 2–5 latach.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Klein (1946); Kernberg (1975); Yeomans i wsp. (2015, TFP)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz *splitting* (sekcja 01) — mechanizm preedypalny niemożności integracji. **2** · Zrozumiesz **cztery fazy cyklu** (sekcja 02): idealizacja → rozczarowanie → dewaluacja → odrzucenie. **3** · Wykonasz integracyjne ćwiczenie z aktualnym partnerem (sekcja 03). **4** · Poznasz protokół TFP — wieloletnia praca z splittingiem (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Cykl idealizacja-dewaluacja to klasyczny mechanizm *splittingu* opisany przez Melanie Klein (1946) jako pierwotny tryb preedypalny — dziecko nie integruje dobrego i złego w jednym obiekcie. Ma „dobrą mamę” (gdy karmi) i „złą mamę” (gdy odmawia) jako *dwa różne* obiekty. NPD utrzymuje ten tryb w dorosłości: dzielenie świata na **ideałów i potworów** chroni przed ambiwalencją. Kernberg (1975) rozwinął koncepcję dla zaburzenia osobowości borderline (BPD) i narcystycznej organizacji osobowości. *Mechanizm w relacji:* partner jest na początku „idealny” (faza idealizacji), a potem nagle „bezwartościowy” (faza dewaluacji), bo pacjent z NPD **nie** jest w stanie zintegrować dobrych i złych aspektów drugiej osoby w jednym obrazie. Pacjent *nie kłamie* — naprawdę widzi partnera w *jednym* obrazie naraz. Dewaluacja jest zwykle reakcją na *narcissistic injury*: rozczarowanie, krytyka, autonomia partnera, konfrontacja z jego/jej wadami. *Partner przeżywa traumatyczny zwrot:* jeszcze tydzień temu „miłość życia”, dziś „toksyczna osoba”. Bez psychoedukacji to **dezorientujące i destrukcyjne** doświadczenie. *Terapeutycznie:* Yeomans, Clarkin & Kernberg (2015) w *Transference-Focused Psychotherapy* (TFP) operacjonalizują pracę z splittingiem w protokole. Terapeuta wskazuje w sesji na „dwa obrazy partnera” i pyta: „który jest prawdziwy?” Pacjent stopniowo uczy się, że **oba są prawdziwe** — partner jest złożony, ani idealny, ani potworny. Wymaga 2–5 lat pracy w protokole 2 sesje/tydzień. Osiąga *remisję strukturalną* u około 50% pacjentów (Yeomans i wsp. 2015). To wynik *najbardziej* trwały — bo zmienia samą strukturę przetwarzania, nie tylko objawy.

01

Splitting — niemożność integracji

CO WIDZI PACJENT Z NPD

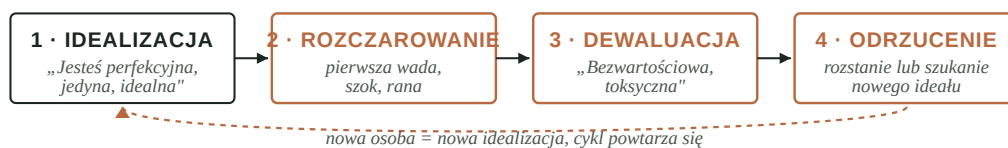
„**Albo** ideał, **albo** potwór.” Brak miejsca na ambiwalencję. Partner jest „cudowny” *lub* „okropny” — nigdy „dobry z wadami”. Przełączanie bywa *natychmiastowe*.

CO WIDZI OSOBA DOJRZAŁA

„Partner jest **złożony**.” Mam jego zalety i jego wady *w jednym obrazie*. Mogę kochać i być rozczarowany jednocześnie. Tolerancja *ambiwalencji*.

Klein (1946): integracja dobrego i złego obiektu to *kluczowy* etap rozwoju emocjonalnego — pojawia się około 2–3 roku życia jako tzw. pozycja *depresyjna*. Pacjenci z NPD utrzymują wcześniejszą *schizoidalno-paranoidalną* pozycję preedypalną.

02 © Cztery fazy cyklu



Czas trwania faz: idealizacja zwykle 3-12 miesięcy (czasem lata u długoletnich partnerów), dewaluacja przyspiesza wraz z latami. **Wyzwalacze dewaluacji:** wada partnera (każdy ma), autonomia (partner odmawia, ma własne potrzeby), *narcissistic injury* (partner krytykuje), porównanie z idealną fantazją.

03 ✎ Integracyjne ćwiczenie

Pomyśl o aktualnym partnerze, bliskim przyjacielu lub osobie, której właśnie nie znosisz. Wypełnij *oba pola*. Cel: trening tolerancji ambiwalencji — kluczowa umiejętność, której uczy TFP.

ZALETY TEJ OSOBY

— co cenisz, podziwiasz, lubisz

WADY TEJ OSOBY

— co Cię drażni, rozczarowuje, boli

Cel: trzymać obraz **zalet i wad jednocześnie**, bez przełączania na „albo-albo”. Pytanie: „Czy mogę kochać tę osobę z tymi wadami?” — odpowiedź „tak” oznacza **integrację**.

04 🗨️ Protokół TFP — Kernberg, Clarkin, Yeomans

STRUKTURA

2 sesje/tydzień przez 2-5 lat. Praca z przeniesieniem (ang. *transference*) — pacjent *splittinguje* też terapeutę. Terapeuta wskazuje na „dwa obrazy” w sesji.

WYNIKI

Remisja strukturalna u ~**50%** pacjentów (Yeomans 2015). To zmiana *struktury* przetwarzania, nie tylko objawów — efekt trwały po zakończeniu terapii.

Klucz: *splitting* to *okulary binarne* — widzisz czarno lub biał, nigdy szaro. Terapia **zdejmuje te okulary**, ale wymaga lat. Praca ze *splittingiem* wymaga *silnego aliansu* i wieloletniej terapii (TFP, 2 sesje/tydzień, 2-5 lat). Wczesne wymuszanie integracji aktywuje wstyd („widzę, że jestem niedojrzały”) → obrona → ucieczka. *Imagery rescripting* wczesnych scen *splittingu* może uzupełniać TFP. Wynik: remisja strukturalna u około 50% — **najbardziej trwała** zmiana dostępna dla NPD (Yeomans i wsp. 2015). Dla partnerów osób z NPD: psychoedukacja o tym mechanizmie jest *fundamentem* — bez niej traumatyczny zwrot z „ideału” w „potwora” jest niezrozumiały i destrukcyjny.